

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Decitabine 50mg (다코젠주, 한국안센)

☐ 제형, 성분함량 :

- 1 병 중 decitabine 50mg

☐ 효능 효과 :

- 일차성 및 이차성 골수이형성증후군

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

2007년 제13차 약제급여평가위원회 : 2007년 12월 21일

2008년 제 3차 약제급여평가위원회 : 2008년 2월 22일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2008년 2월 1일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 급여

- 신청품은 ‘일차성 및 이차성 골수이형성증후군’에 허가받은 약제로 허가사항 용법 용량과 함께 보험등재신청 용법용량이 임상진료 지침에 언급되어 있고 임상 시험에서 효과가 인정됨. 보험등재 신청 용량의 투약비용은 azacitidine과 유사하고, 식약청 허가용량의 투약비용은 azacitidine보다 고가이나 허가된 용법용량에 의한 사용이 많지 않을 것으로 예상되며, 대상 환자수가 적으므로 급여로 평가됨.

○ 급여기준

- 투여대상

“Bone marrow blasts가 20% 이하인 골수형성이상증후군(MDS)”으로 확진된 환자로서 다음의 가, 나 중 한 가지 이상을 만족하는 경우

가. IPSS Risk category 중 Intermediate-1인 환자로서 다음 중 1가지 이상에 해당하는 환자

- (1) 빈혈이 erythropoietin 또는 antithymocyte globulin에 반응하지 않는 경우
- (2) 빈혈과 함께 절대호중구수 $1,800/\text{mm}^3$ 미만의 호중구감소증이 있는 경우
- (3) 빈혈과 함께 혈소판 수 $100,000/\text{mm}^3$ 미만의 혈소판감소증이 있는 경우

나. IPSS Risk category 중 Intermediate-2 또는 High인 환자로서 등중조혈모세포이식을 시행할 수 없는 경우

※ IPSS : International Prognostic Scoring System

※ 허가사항 범위이지만 상기 인정기준 이외에 투여하는 경우의 비용부담은 보건복지부 고시 【제2007-54호(’07.7.1시행)】에 따라 약값 전액을 본인이 부담토록 함

주 투여용량은 허가초과 용법·용량이나, “치료 1주기당 $20\text{mg}/\text{m}^2$ 을(1시간 동안 정맥 점적주입) 연속 5일간 시행하고, 이후 치료주기를 매4주 간격으로 반복투여”하는 방법으로 투여하는 것을 권장함

나. 평가 내용

○ 진료상 반드시 필요한 약제 여부

- 신청품은 “일차성 및 이차성 골수이형성증후군”에 허가받은 약제로, 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 약제가(azacitidine)가 기등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시, 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않는 것으로 사료됨.

○ 임상적 유용성

- 교과서¹⁾에 의하면 신청품은 azacitidine과 유사한 구조이나, 신청품이 좀더 potent한 hypomethylating activity를 가지며, common toxicity로는 myelosuppression을 보임.
- '08년 NCCN 지침²⁾에서 의하면 MDS에 hypomethylating agent로 신청품과 azacitidine을 권장하고 있으며, 신청품의 경우 허가용량과 보험신청 용량을 모두 언급함.

- 임상시험에서 효과가 인정되나, 신청품의 보험신청 용량과 허가용량에서 비교약제인 azacitidine과의 직접비교 임상 시험이 없으며, 각 임상 문헌마다 MDS 환자군의 특성이 달라 이를 보정한 메타분석 등이 필요함.
- 문헌 검토결과 ³⁾⁴⁾⁵⁾ 신청품은 보험등재 신청 용법·용량에서 CR+PR 값은 35%~37%로 허가용법용량(17%) 및 azacitidine(11%)보다 높았음. CR+PR+HI값의 경우 보험신청 용량에서 47%로 azacitidine과 유사한 값을 보이거나 허가용량에 (30%) 비해서는 높았음.
- 보험등재 신청 용법·용량은 임상자료 등을 통하여 허가 용법·용량에 비해 독성은 적고 더 높은 반응율과 소요비용은 적게 소요됨.⁶⁾

○ 비용 효과성

- 신청품은 ‘골수 이형성증후군의 치료’에 허가받은 azacitidine을 대체약제 및 비교약제로 선정함.
- 제약사가 경제성 평가를 제출하지 않았으며, azacitidine과의 비교임상시험이 없으므로 신청품과 azacitidine의 투약비용을 비교한 결과, 허가 용량으로는 1주기 투약비용 [REDACTED]이 azacitidine의 1주기 투약비용 [REDACTED]에 비하여 고가에 해당하나, 보험신청 용량의 경우 1주기 투약비용 [REDACTED]이 azacitidine과 동일함.

○ 보험재정에 미치는 영향

- 보험신청 용량에 대한 실제 임상 사용이 예상되나⁷⁾, 허가 용량을 [REDACTED] 사용시 등재 후 1~3년차(보험신청 용량과 허가 용량 제약사 제시 대체률로 소요비용 산출)까지는 [REDACTED] 재정부담이 증가함.
- 다만, 등재 3년 이후 제약사가 허가 용법용량을 변경시 모두 보험 등재 용법으로 사용할 경우 재정 부담은 신청품 도입 전 연간 소요 비용과 동일할 것임.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국에 등재되어 있음

REFERENCE

- 1) Clinical Oncology 3th, 2004(Elsevier churchill livingstone), Cancer, principle & practice of oncology 7th, PDR(2007), Williams Hematology 7th(2006)
- 2) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology V.2.2008
- 3) Cancer 2006;107:1794~1803
- 4) Blood 2007;109:52-57
- 5) JCO, Vol 20(10), 2002: 2429-244
- 6) 대한조혈모세포이식학회(대조학 2007-61, 2007. 10. 2), 대한혈액학회(대혈학 2007-120, 2007.10.2) 및 암질환심의위원회
- 7) 대한조혈모세포이식학회(대조학 2007-61, 2007. 10. 2), 대한혈액학회(대혈학 2007-120, 2007.10.2) 및 암질환심의위원회